

HIV/AIDS 患者疲乏相关症状群管理的最佳证据总结

徐丹¹ 张江辉² 申兰¹ 杜晓丹³ 邱业银⁴ 孙燕侠⁵

¹遵义医科大学珠海校区护理学系, 珠海 519040; ²遵义医科大学第五附属(珠海)医院感染科, 珠海 519100; ³遵义医科大学第五附属(珠海)医院体检科, 珠海 519100; ⁴遵义医科大学第五附属(珠海)医院急诊科, 珠海 519100; ⁵遵义医科大学第五附属(珠海)医院小儿肛肠科, 珠海 519100

通信作者: 张江辉, Email: zhang.jiang.hui@163.com

【摘要】目的 总结 HIV/AIDS 患者疲乏相关症状群管理的最佳证据。**方法** 根据“6S”模型自上而下依次检索 BMJ Best Practice、UpToDate、澳大利亚乔安娜布里格斯研究所循证卫生保健中心数据库、美国国家指南库、英国国家卫生与临床优化研究所、医脉通、联合国艾滋病规划署、Cochrane Library、PubMed、Embase、中国知网、万方数据库、中国生物医学文献数据库等数据库和网站中有关 HIV/AIDS 患者疲乏相关症状群管理的文献, 包括临床决策、指南、专家共识、系统评价、Meta 分析、证据总结和随机对照试验。检索时限为 2017 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 30 日。由 2 名研究人员独立采用相应的文献质量评价工具评价纳入文献的方法学质量, 并提取和汇总 HIV/AIDS 患者疲乏相关症状群管理的最佳证据。**结果** 共纳入 20 篇文献, 包括 7 篇临床决策、3 篇指南、2 篇证据总结、1 篇专家共识、3 篇系统评价和 4 篇随机对照试验。最终从疲乏管理、衰弱管理、性功能障碍管理及睡眠障碍管理 4 个方面汇总了 34 条证据。**结论** 本研究总结了 HIV/AIDS 患者疲乏相关症状群管理的最佳证据, 医护人员需结合临床情境, 有针对性地选择、应用证据。

【关键词】 获得性免疫缺陷综合征; 疲乏; 症状群; 管理; 证据总结

基金项目: 2024 年度珠海市卫生医学科研项目(2420009000034)

DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20240119-00386

Summary of the best evidence for management of fatigue related symptom clusters in HIV/AIDS patients

Xu Dan¹, Zhang Jianghui², Shen Lan¹, Du Xiaodan³, Qiu Yeyin⁴, Sun Yanxia⁵

¹School of Nursing, Zhuhai Campus of Zunyi Medical University, Zhuhai 519040, China; ²Department of Infectious Diseases, the Fifth Affiliated (Zhuhai) Hospital of Zunyi Medical University, Zhuhai 519100, China; ³Department of Physical Examination, the Fifth Affiliated (Zhuhai) Hospital of Zunyi Medical University, Zhuhai 519100, China; ⁴Emergency Department, the Fifth Affiliated (Zhuhai) Hospital of Zunyi Medical University, Zhuhai 519100, China; ⁵Pediatric Proctology Department, the Fifth Affiliated (Zhuhai) Hospital of Zunyi Medical University, Zhuhai 519100, China

Corresponding author: Zhang Jianghui, Email: zhang.jiang.hui@163.com

【Abstract】Objective To summarize the best evidence for the management of fatigue-related symptom clusters in HIV/AIDS patients. **Methods** According to the "6S" model, clinical decisions, guidelines, expert consensus, systematic reviews, Meta-analysis, evidence summary, and randomized controlled trials on the management of fatigue-related symptom clusters of HIV/AIDS patients were searched from top to bottom in BMJ Best Practice, UpToDate, Joanna Briggs Institute Evidence-Based Health Care Center Database, Agency

收稿日期 2024-01-19 本文编辑 李莺

引用本文: 徐丹, 张江辉, 申兰, 等. HIV/AIDS 患者疲乏相关症状群管理的最佳证据总结[J]. 中华现代护理杂志, 2024, 30(31): 4208-4215. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20240119-00386.

for Healthcare Research and Quality, National Institute for Health and Clinical Excellence, Medlive, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, Cochrane Library, PubMed, Embase, China National Knowledge Infrastructure, WanFang data, China Biology Medicine disc and other databases and websites. The search period was from January 1, 2017, to July 30, 2023. Two researchers independently used corresponding quality evaluation tools to evaluate the methodological quality of the included literature. They extracted and summarized the best evidence for the management of fatigue-related symptom clusters in HIV/AIDS patients. **Results** A total of 20 articles were included, including seven clinical decisions, three guidelines, two evidence summaries, one expert consensus, three systematic reviews, and four randomized controlled trials. Thirty-four pieces of evidence were summarized from four aspects: fatigue management, frailty management, sexual dysfunction management, and sleep disorder management. **Conclusions** This study summarizes the best evidence for the management of fatigue-related symptom clusters in HIV/AIDS patients. Medical and nursing staff must select and apply the evidence in a targeted manner based on clinical situations.

【Key words】 Acquired immunodeficiency syndrome; Fatigue; Syndrome; Management; Evidence summary

Fund program: 2024 Zhuhai Health and Medical Research Project(2420009000034)

DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20240119-00386

艾滋病又称获得性免疫缺陷综合征(acquired immunodeficiency syndrome, AIDS), 是一种由人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)引起, 且伴全身免疫系统严重损害的传染性疾病^[1]。抗逆转录病毒治疗(antiretroviral therapy, ART)是目前全球公认最有效的艾滋病治疗方法^[2]。然而, HIV/AIDS 患者在治疗过程中因疾病、药物治疗及社会心理等因素影响^[3]会同时出现多种症状, 这些症状相互作用、影响, 形成症状群^[4], 其中疲乏、衰弱、性功能障碍、睡眠障碍最常见, 这些症状共同构成了疲乏相关症状群^[5]。与单一症状相比, 疲乏相关症状群会导致 HIV/AIDS 患者的治疗依从性、治疗效果、生活质量降低, 病死率增加^[6-9]。近年来, 帮助 HIV/AIDS 患者改善疲乏相关症状群已成为医护人员关注的重点^[10]。然而, 目前关于疲乏症状群管理的证据较为分散。本研究旨在总结 HIV/AIDS 患者疲乏相关症状群管理的最佳证据, 为医护人员制订干预措施提供参考。本研究已在复旦大学循证护理中心注册(注册号: ES20233461)。

一、资料与方法

1. 确立研究问题: 根据“PIPOST”模式确立研究问题^[11-12]。目标人群(population, P): 年龄≥18 岁的 HIV/AIDS 患者; 干预措施(intervention, I): 疲乏相关症状群干预方法; 实施者(professional, P): 医护人员; 结局指标(outcome, O): 疲乏、衰弱、性功能障碍、睡眠障碍等症状; 证据应用环境(setting, S): 医院、社区、家庭等; 证据类型(type of evidence, T): 临床决策、指南、专家共识、证据总结、Meta 分析、系统评价和随机对照试验。

2. 文献检索策略: 根据“6S”模型自上而下检索 BMJ Best Practice、UpToDate、澳大利亚乔安娜布里格斯研究所(Joanna Briggs Institute, JBI)循证卫生保健中心数据库、美国国家指南库(National Guideline Clearinghouse, NGC)、加拿大安大略护理学会(Registered Nurses' Association of Ontario, RANO)、英国国家卫生与临床优化研究所(National Institute for Health and Care Excellence, NICE)、苏格兰院际指南网

(Scottish Interecollegiate Guidelines Network, SIGN)、美国国立卫生研究院(National Institutes of Health, NIH)、世界卫生组织(World Health Organization, WHO)、联合国艾滋病规划署(The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, UNAIDS)、Cochrane Library、医脉通、PubMed、Embase、EBSCO、中国知网、万方数据库、维普网和中国生物医学文献数据库。以“艾滋病/获得性免疫缺陷综合征/HIV/AIDS”“症状管理/症状群/症状组学”“疲乏/疲劳/乏力/疲倦”“睡眠障碍/失眠/睡眠质量/入睡困难/睡眠异常/睡眠剥夺”“衰弱/虚弱”“性功能障碍”“临床决策/指南/专家共识/最佳实践/证据总结/系统评价/Meta 分析/随机对照试验”为中文检索词, 以“HIV/AIDS/acquired immunodeficiency syndrome/human immunodeficiency virus”“symptomomics/symptom management/symptom cluster”“fatigue/tired*/lassitude/asthenia”“sleep initiation and maintenance disorders/sleep disorder*/sleeplessness/sleep disturbances”“frailty/weakness”“sexual dysfunction/sexual disorder”“guideline*/systematic reviews/meta-analysis/consensus/clinical practice/best practice/evidence summary/randomized controlled trials”为英文检索词检索中英文数据库和相关网站, 检索时限为 2017 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 30 日。

3. 文献的纳入与排除标准: 纳入标准。(1)研究对象为≥18 岁的 HIV/AIDS 患者。(2)研究内容涉及疲乏、睡眠障碍、衰弱及性功能障碍等症状的管理。(3)文献类型为临床决策、指南、专家共识、最佳临床实践、证据总结、系统评价、Meta 分析和随机对照试验。(4)文献语言为中、英文。排除标准。(1)无法获取全文的文献。(2)已更新的指南。(3)质量评价低的文献。

4. 文献质量评价方法: 将来自 BMJ Best Practice、UpToDate、JBI 循证卫生保健中心数据库等的临床决策和证据总结作为高质量证据直接纳入。对于来自其他数据库的临床决策与证据总结, 需追溯原始文献, 采用 JBI 循证卫生保健中心制订的相应文献质量评价工具进行评价^[13]。指南采

用英国临床指南研究与评价系统 II (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation, AGREE II)^[14] 进行质量评价。AGREE II 包括 6 个领域, 由 23 个条目和附加 2 个全面评价条目组成, 各条目从“很不同意”至“很同意”依次计 1~7 分; 各领域得分为该领域中所有条目得分的总和, 并标准化为该领域可能的最高分数的百分比[标准化得分=(实际得分—最低可能得分)/(最高可能分值—最低可能分值)×100%], 得出指南的推荐等级; 推荐等级分为 3 级, 其中 A 级为所有领域得分均≥60%, 可直接推荐; B 级为>2 个领域的得分≥30%, 但存在<60% 的领域, 提示决策者在应用时需谨慎权衡利弊; C 级为≥3 个领域得分<30%, 暂不推荐使用。系统评价、专家共识采用 JBI 循证卫生保健中心相应的质量评价工具(2016 版)进行评价^[15], 其中系统评价分析质量评价工具共 11 个条目, 专家共识质量评价工具共 6 个条目, 各条目的评价标准为“是、否、不清楚、不适用”。随机对照试验采用 Cochrane 手册(5.1.0 版)评价^[16]。由经过循证护理课程培训的 2 名全日制硕士研究生独立评价文献的方法学质量, 若意见不一致, 则与第 3 名研究人员讨论后决定。

5. 证据汇总与分级: 由 2 名研究人员独立提取、汇总证据。证据汇总原则如下: 当证据相同或互补时, 进行合并及概述; 当证据存在冲突时, 遵循高质量证据优先、最新发表证据优先的原则。采用 JBI 循证卫生保健中心的 2014 版 JBI 证据预分级及证据推荐级别系统^[15]将证据等级划分为 1a~5c 级, 其中 1a 级别最高, 5c 级别最低。由本研究循证小组成员基于 JBI 循证卫生保健中心的 FAME 结构进行讨论并评价证据的可行性、适宜性、临床意义和有效性, 最终确定推荐级别为 A 级(强推荐)或 B 级(弱推荐)。

二、结果

1. 文献筛选结果: 检索初步获得文献 2 868 篇, 经过剔除

和阅读标题、摘要、全文排除不相关文献, 并通过追溯相关参考文献, 最终纳入 20 篇文献^[17-36], 包括 7 篇临床决策^[17-23]、3 篇指南^[24-26]、2 篇证据总结^[27-28]、1 篇专家共识^[29]、3 篇系统评价^[30-32]和 4 篇随机对照试验^[33-36]。文献筛选流程图见图 1。20 篇纳入文献的基本特征见表 1。

2. 纳入文献质量评价结果: (1) 纳入临床决策的质量评价结果。共纳入 7 篇临床决策^[17-23], 均来自 UpToDate, 直接纳入。(2) 纳入指南的质量评价结果。共纳入 3 篇指南^[24-26], 推荐级别均为 B 级, 予以纳入。见表 2。(3) 纳入证据总结的质量评价结果。共纳入 2 篇证据总结^[27-28], 均来自 JBI 循证卫生保健中心数据库, 直接纳入。(4) 纳入专家共识的质量评价结果。共纳入 1 篇专家共识^[29], 在所有评价条目的结果均为“是”, 质量较高, 予以纳入。(5) 纳入系统评价质量评价结果。共纳入 3 篇系统评价^[30-32], 其中 Xiao 等^[30]除在条目 10、11 评价为“不清楚”外, 其余条目均评价为“是”; Huntingdon 等^[31]除在条目 8 评价为“不清楚”外, 其余条目均评价为“是”; De Crescenzo 等^[32]除在条目 6 评价为“不清楚”外, 其余条目均评价为“是”。见表 3。3 篇系统评价整体质量较高, 均予以纳入。(6) 纳入随机对照试验的质量评价结果。共纳入 4 篇随机对照试验^[33-36], 其中 Ramirez Garcia 等^[33]除在条目 3、4、7 评价为“不清楚”外, 其余条目均评价为“低风险偏倚”; Han 等^[34]在全部条目均评价为“低风险偏倚”; Alikhani 等^[35]除在条目 2、3、7 评价为“不清楚”外, 其余条目均评价为“低风险偏倚”; Kuloor 等^[36]除在条目 2、3、4 评价为“不清楚”外, 其余条目均评价为“低风险偏倚”。见表 4。4 篇随机对照试验整体质量较高, 均予以纳入。

3. 证据描述与汇总: 本研究从疲乏管理、衰弱管理、性功能障碍管理及睡眠障碍管理 4 个方面总结了 34 条证据。见表 5。

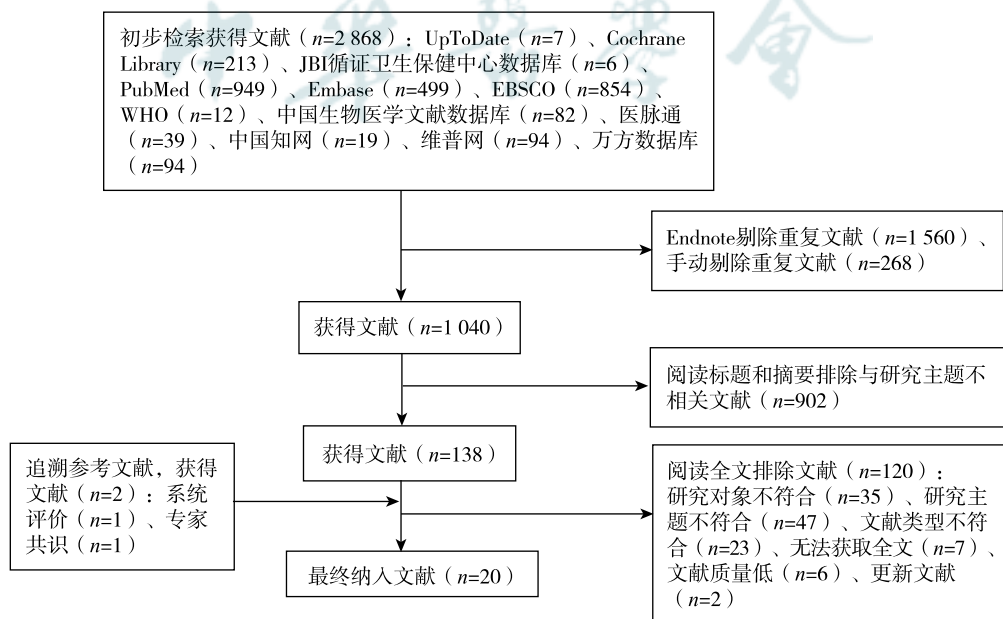


图1 文献筛选流程图

表 1 20 篇纳入文献的基本特征

纳入文献	发表年份	文献类型	文献来源	研究主题
Kryger 等 ^[17]	2023	临床决策	UpToDate	成人阻塞性睡眠呼吸暂停的治疗
Greene 和 Gandhi ^[18]	2023	临床决策	UpToDate	老年 HIV 感染症状管理
Walston 和 Schmader ^[19]	2023	临床决策	UpToDate	衰弱症的管理
Khera 和 Snyder ^[20]	2023	临床决策	UpToDate	男性性功能障碍的治疗
Shifren 和 Barbieri ^[21]	2023	临床决策	UpToDate	女性性功能障碍的治疗
Fosnocht 等 ^[22]	2021	临床决策	UpToDate	成人疲劳的管理
Pahuja 等 ^[23]	2021	临床决策	UpToDate	舒缓医疗中成人 HIV/AIDS 问题
European Association of Urology ^[24]	2021	指南	医脉通	性与生殖健康——男性性功能障碍
European AIDS Clinical Society ^[25]	2021	指南	医脉通	艾滋病的治疗
Riemann 等 ^[26]	2017	指南	PubMed	失眠症的诊断和治疗
Valdez ^[27]	2022	证据总结	JBI 循证卫生保健中心数据库	男性性功能障碍生活方式干预措施
Oerlemans ^[28]	2022	证据总结	JBI 循证卫生保健中心数据库	女性性功能障碍生活方式干预措施
中华医学会呼吸分会睡眠呼吸障碍学组和中国医学装备协会呼吸病学装备技术专业委员会睡眠呼吸设备学组 ^[29]	2022	专家共识	中国知网	成人阻塞性睡眠呼吸暂停高危人群筛查与管理
Xiao 等 ^[30]	2020	系统评价	PubMed	非药物干预对减少 HIV/AIDS 患者疲乏的有效性
Huntingdon 等 ^[31]	2020	系统评价	PubMed	HIV/AIDS 患者中一般性功能和性满意度的相关因素
De Crescenzo 等 ^[32]	2022	系统评价	EBSCO	药物干预对成人失眠症的短期和长期管理的效果比较
Ramirez Garcia 等 ^[33]	2023	随机对照试验	EBSCO	自生训练对 HIV/AIDS 患者生活质量和症状的影响
Han 等 ^[34]	2021	随机对照试验	PubMed	移动健康症状管理程序改善 HIV/AIDS 患者相关症状的效果
Alikhani 等 ^[35]	2020	随机对照试验	PubMed	睡眠障碍治疗对 HIV/AIDS 患者睡眠、心理和认知功能及生物标志物的影响
Kuloor 等 ^[36]	2019	随机对照试验	PubMed	瑜伽对 HIV/AIDS 患者生活质量的影响

表 2 3 篇纳入指南的方法学质量评价结果

纳入文献	各领域标准化百分比(%)						≥ 60% 的 领域数(个)	≥ 30% 的 领域数(个)	推荐级别 (级)
	范围和目的	参与人员	严谨性	清晰性	应用性	独立性			
European Association of Urology ^[24]	83.3	55.5	48.9	80.5	50.0	58.3	2	6	B
European AIDS Clinical Society ^[25]	75.0	94.4	45.8	83.3	37.5	33.3	3	6	B
Riemann 等 ^[26]	91.6	77.7	48.9	55.5	31.2	58.3	2	6	B

三、讨论

尽早识别 HIV/AIDS 患者疲乏相关症状群的高危因素：第 1、9、16、24~25 条证据总结了 HIV/AIDS 患者疲乏相关症状群的影响因素，其中焦虑、抑郁是 HIV/AIDS 患者疲乏、衰弱、性功能障碍和睡眠障碍共同的影响因素。原因可能是 HIV/AIDS 患者因疾病特殊性易发生较强的心理应激反应，导致社会活动减少、身体功能下降^[31, 37-39]，进而导致疲乏相关症状群发生率增加。

全面正确评估 HIV/AIDS 患者疲乏相关症状群，给予患者针对性管理：针对性症状管理有助于提高 HIV/AIDS 患者的疾病治疗效果、功能状态和生活质量^[40]，因此对患者进行全面、正确的评估十分重要。第 2~3、10~11、17~18、26 条证据阐述了 HIV/AIDS 患者疲乏相关症状群的评估内容，证

据主要来自临床决策和指南。医护人员在评估患者疲乏症状时，应重点评估睡眠状况、精神疾病和基础病因情况^[23]；对于 > 50 岁的患者，应重点评估衰弱症状^[25]。然而，目前尚无针对疲乏症状群的评估工具，仅可针对单一症状选择评估工具。使用经过验证且合适的症状评估工具可以全面、准确地评估患者相关症状^[20-22, 25-26]。

选择药物治疗时应重点关注药物之间的相互作用：第 4、12、19~20、27~28 条证据阐述了 HIV/AIDS 患者疲乏相关症状群的药物治疗内容，证据主要来源于临床决策和指南。第 12 条证据强调了切换抗逆转录病毒药物治疗的重要性^[25]，相较于多替拉韦、恩曲他滨和替诺福韦艾拉酚胺治疗，经阿巴卡韦、多替拉韦和拉米夫定治疗的患者出现疲乏/虚弱、悲伤/抑郁、紧张/焦虑、睡眠障碍等情况较少^[41]。同时，医

表3 3篇纳入系统评价的方法学质量评价结果

纳入文献	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
Xiao等 ^[30]	是	是	是	是	是	是	是	是	是	不清楚	不清楚
Huntingdon等 ^[31]	是	是	是	是	是	是	是	不清楚	是	是	是
De Crescenzo等 ^[32]	是	是	是	是	是	不清楚	是	是	是	是	是

注：①所提出的循证问题是否清晰、明确？②文献纳入标准对该循证问题来说是否恰当？③检索策略是否恰当？④检索文献的数据库或资源是否充分？⑤采用文献质量评价标准是否恰当？⑥是否由2名或2名以上的评价者独立完成文献质量评价？⑦提取资料时是否采取一定的措施减少误差？⑧合并研究的方法是否恰当？⑨是否评估了发表偏倚的可能性？⑩所提出的政策或实践推荐建议是否基于系统评价结果？⑪提出的进一步研究方向是否恰当？

表4 4篇纳入随机对照试验的方法学质量评价结果

纳入文献	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Ramirez Garcia等 ^[33]	低风险偏倚	低风险偏倚	不清楚	不清楚	低风险偏倚	低风险偏倚	不清楚
Han等 ^[34]	低风险偏倚	低风险偏倚	低风险偏倚	低风险偏倚	低风险偏倚	低风险偏倚	低风险偏倚
Alikhani等 ^[35]	低风险偏倚	不清楚	不清楚	低风险偏倚	低风险偏倚	低风险偏倚	不清楚
Kuloor等 ^[36]	低风险偏倚	不清楚	不清楚	不清楚	低风险偏倚	低风险偏倚	低风险偏倚

注：①随机序列的产生？②对随机方案的分配隐藏？③对研究对象及干预者实施盲法？④对结果测评者实施盲法？⑤结局指标数据的完整性？⑥选择性报告结果的可能性？⑦其他方面的偏倚来源？

护人员应重点关注药物的不良反应，如治疗疲乏的兴奋剂（如莫达非尼、阿莫达非尼、右苯丙胺及哌甲酯）可导致患者发生睡眠障碍^[25-26]；对于男性性功能障碍患者，应提醒其避免将娱乐性药物与PD5阻滞剂联合使用，如当育亨宾氢化胆洛利与抗逆转录病毒药物联合使用时，会增加高血压病的发生风险^[25]。因此，在进行药物治疗时，医护人员应向患者宣教药物的不良反应。

合适的非药物干预方式是改善HIV/AIDS患者疲乏相关症状群的核心：第5~8、13~15、21~23、29~34条阐述了HIV/AIDS患者疲乏相关症状群的非药物干预内容，证据主要来源于临床决策、指南及证据总结。非药物干预中的认知行为疗法可作为治疗疲乏症状群的主要方法之一。研究显示，认知行为疗法对提高HIV/AIDS患者应对技能和问题解决能力具有重要作用^[42]。由于认知行为疗法干预周期长且需要治疗师参与，因此应在专业人员的指导下实施和随访。健康教育^[27-28]、运动^[25, 30, 36]、生活方式干预^[19, 27-28]和减重^[17, 27]同样是HIV/AIDS患者疲乏症状群的干预措施。健康教育虽然是提高HIV/AIDS患者自我管理水平的有效方式，但目前仍存在教育内容不全面、针对性不强等问题，因此建议医护人员制订系统化、规范化的健康教育方案^[43]。在指导HIV/AIDS患者运动时，医护人员应协助患者选择合适的运动方式和强度，并讲解注意事项，同时做好随访管理工作^[44]。在为患者制订生活方式干预及减重方案时，可以将自我效能作为干预关键点^[45]。

综上所述，本研究从疲乏管理、衰弱管理、性功能障碍管理及睡眠障碍管理4个方面总结了34条HIV/AIDS患者疲乏相关症状群管理的最佳证据，可为医护人员提供参考。然而，针对HIV/AIDS患者疲乏相关症状群的原始研究较少，因此本研究总结的是单一症状的证据，对HIV/AIDS患者疲乏相关症状群的管理效果需进一步验证。由于本研究纳入的

文献多来自国外，因此在医护人员应用证据时，建议结合临床情境及患者自身情况选择合适的证据。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 徐丹：构思与设计、证据提取与汇总、论文撰写与修订；申兰：文献检索、整理与质量评价；杜晓丹：文献检索与整理、论文审校；邱业银：文献质量评价、论文审校；孙燕侠：论文审校；张江辉：研究指导、文献质量评价、论文修订与审校

参 考 文 献

[1] 杨国莉, 严谨. 艾滋病患者求医行为及影响因素的研究进展[J]. 中华现代护理杂志, 2012, 18(18): 2218-2220. DOI: 10.3760/ema.j.issn.1674-2907.2012.18.040.
Yang GL, Yan J. Progress of research on medical seeking behavior and influencing factors of AIDS patients[J]. Chin J Mod Nurs, 2012, 18(18): 2218-2220.

[2] 刘亚楠, 李鹏宇, 桑锋, 等. ART后不同免疫水平的HIV/AIDS患者免疫功能和肠道菌群变化分析[J/OL]. 中国皮肤性病学杂志, 1-10 [2023-09-08]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1197.R.20231226.0901.002.html>.

[3] Boyer V, Vilotitch A, Marcellin F, et al. Self-reported bothersome symptoms across different socioepidemiological groups of people living with HIV attending french hospitals: results from the ANRS-VESPA2 survey[J]. J Pain Symptom Manage, 2017, 54(1): 110-119. DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2017.03.010.

[4] Namisango E, Harding R, Katabira ET, et al. A novel symptom cluster analysis among ambulatory HIV/AIDS patients in Uganda[J]. AIDS Care, 2015, 27(8): 954-963. DOI: 10.1080/09540121.2015.1020749.

[5] Zhu Z, Zhao R, Hu Y. Symptom clusters in people living with HIV: a systematic review[J]. J Pain Symptom Manage, 2019, 58(1): 115-133. DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2019.03.018.

[6] Bloch M. Frailty in people living with HIV[J]. AIDS Res Ther, 2018, 15(1): 19. DOI: 10.1186/s12981-018-0210-2.

表 5 HIV/AIDS 患者疲乏相关症状群管理的证据总结

主题	证据描述	证据等级	推荐强度
疲乏管理	影响因素 1. 生理因素包括肝脏疾病、甲状腺功能减退症、性腺功能减退症、贫血及 HIV 感染持续时间等; 心理社会因素包括抑郁、焦虑、创伤后应激障碍、应激性生活事件和低收入等 ^[23]	1b	A
	症状评估 2. 评估重点: 患者躯体或精神病因、服用药物、睡眠及基础疾病治疗情况 ^[22-23]	5b	A
	3. 评估工具: 推荐使用 HIV 相关疲乏量表 ^[23]	5c	B
	药物治疗 4. 推荐使用睾酮、兴奋剂(如莫达非尼、阿莫达非尼、右苯丙胺及哌甲脂)治疗患者疲乏, 但莫达非尼和阿莫达非尼需谨慎 ^[23] ; 对于存在抑郁症状的患者应采取抗抑郁治疗 ^[22]	1a	B
	非药物干预 5. 推荐使用相关移动应用健康程序治疗患者疲乏症状 ^[34]	1c	B
	6. 对患者进行一系列每次持续 1 h 的认知行为治疗课程, 改变可能阻碍其康复的信念和行为 ^[22]	5c	B
	7. 在病情允许情况下, 鼓励患者进行体能训练(如抗阻运动、有氧运动) ^[30]	1a	A
	8. 推荐患者进行每周 5 次、每次 1 h 的瑜伽练习 ^[36]	1a	B
衰弱管理	影响因素 9. 高龄、抑郁、慢性阻塞性肺疾病、认知障碍、CD4 细胞计数偏低、病毒血症、体重指数异常等是衰弱的影响因素 ^[18-19, 25]	5b	A
	症状评估 10. 评估重点: 推荐对 ≥ 50 岁的患者进行衰弱评估 ^[19, 25]	5c	A
	11. 评估工具: 推荐使用衰弱量表、简短身体功能量表 ^[25] 等工具对患者进行评估	3c	A
	药物治疗 12. 建议交替使用一种或多种抗逆转录病毒药物, 降低药物的不良反应 ^[25]	5c	B
	非药物治疗 13. 对于体重减轻的患者, 筛查可干预的原因, 考虑食物强化和蛋白质/热量、维生素 D 的补充 ^[19, 25]	5b	B
性功能障碍管理	14. 给予患者长期生活方式干预(如认知训练, 营养咨询和提供身体活动建议) ^[19]	1c	B
	15. 建议采用抗阻力训练维持患者的身体功能 ^[25]	5c	A
	影响因素 16. 年龄、抑郁、焦虑、性满意度、性腺功能减退、感染、体重指数异常、抗病毒药物治疗时间、蛋白酶抑制剂药物使用、CD4 计数、病毒载量等是性功能障碍的影响因素 ^[25, 31]	4a	B
	症状评估 17. 评估重点: 对患者进行病史和性史的全面评估与检查, 其中总睾酮须在上午(7: 00 和 11: 00)及禁食状态下检测 ^[24]	1a	A
	18. 评估工具: 推荐使用 IIEF 对男性患者进行评估, 使用 FSFI 对女性患者进行评估 ^[20-21, 25]	5c	A
	药物治疗 19. 男性: 推荐将 PDE5、SSRI、睾酮作为治疗勃起功能障碍、早泄、性腺功能减退的一线治疗药物 ^[24]	1a	A
	20. 女性: 使用局部激素治疗、阴道/直肠栓剂、局部利多卡因及辣椒素治疗性交疼痛; 安非他酮和氟班色林治疗性欲低下; PDE5、激素治疗性唤起障碍; 育亨宾氢化胆洛利、PDE 抑制剂、激素及安非他酮治疗性高潮障碍 ^[21, 25]	1a	A
	非药物治疗 21. 推荐将健康教育作为治疗性功能障碍的首要选择, 如生活方式改变及饮食宣教等 ^[27-28]	5c	A
	22. 男性: 推荐将真空勃起装置治疗、低能量体外冲击波治疗、低强度脉冲超声及假体植入手术作为治疗勃起功能障碍的非药物治疗方法 ^[20, 24] 。建议将改善运动方案和限制热量摄入作为降低肥胖男性体重指数的管理策略或辅助治疗措施 ^[27]	1a	A
	23. 女性: 推荐将盆腔物理治疗 ^[25] 、性技能培训、认知行为疗法、正念疗法、配偶疗法 ^[21] 作为治疗性功能障碍的非药物治疗方法	4b	A
睡眠障碍管理	影响因素 24. OSAS: 男性、高龄、肥胖、遗传因素、服用镇静安眠药物及不良生活方式是其影响因素 ^[29]	4b	A
	25. 失眠症: 精神疾病、遗传因素、药物(如兴奋剂、抗抑郁药、阿片类药物)不良反应、睡眠习惯和态度是其影响因素 ^[26]	1c	A
	症状评估 26. 推荐使用信效度高的量表(如匹兹堡睡眠质量指数、失眠严重指数)评估失眠症情况 ^[26] ; 使用阻塞性睡眠呼吸暂停量表筛查 OSAS ^[29]	5c	A
	药物治疗 27. 急性期失眠治疗药物首选苯二氮卓类药物、多西拉敏、右佐匹克隆、Lemborexant、Seltorexant、唑吡坦; 长期治疗优选右佐匹克隆、Lemborexant ^[32]	1a	A
	28. 选择直接或间接刺激呼吸驱动及改善上呼吸道塌陷性的药物、抗毒覃碱药物或去甲肾上腺素能药物治疗 OSAS ^[17]	1c	B
	非药物干预 29. 对患者进行为期 12 周、共 6 个疗程的自生训练。每个疗程 5 ~ 15 min, 每日练习 2 ~ 3 次 ^[33]	1c	B
	30. 推荐将针灸、穴位按摩、芳香疗法、足部反射、冥想运动、艾灸及音乐疗法作为提高睡眠质量的非药物疗法 ^[33]	1b	A
	31. 推荐患者减重(若患者超重或肥胖)、运动、改变睡眠体位(若患者存在体位性 OSAS)、戒酒及避免使用某些抑制中枢神经系统的药物 ^[17]	5b	A
	32. 气道正压治疗为 OSAS 患者的一线治疗方式。若患者存在气道正压治疗的依从性问题, 可采用口腔矫治器治疗 ^[17]	5b	B
	33. 对患者进行睡眠卫生行为教育, 每周 1 次, 每次 50 ~ 60 min, 主要内容为正常睡眠习惯的重要性、促进睡眠的技术及睡觉前的注意事项 ^[35]	1a	A
	34. 推荐使用放松训练、睡眠限制疗法及刺激控制疗法 ^[26]	5b	B

注: HIV, 人类免疫缺陷病毒; AIDS, 获得性免疫缺陷综合征; IIEF, 国际勃起功能评分; FSFI, 女性性功能指数; PDE5, 磷酸二酯酶 5 型抑制剂; SSRI, 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂; PDE, 磷酸二酯酶抑制剂; OSAS, 阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。

- [7] Han S, Hu Y, Pei Y, et al. Sleep satisfaction and cognitive complaints in Chinese middle-aged and older persons living with HIV: the mediating role of anxiety and fatigue[J]. *AIDS Care*, 2021, 33(7): 929-937. DOI: 10.1080/09540121.2020.1844861.
- [8] Huang X, Li H, Meyers K, et al. Burden of sleep disturbances and associated risk factors: a cross-sectional survey among HIV-infected persons on antiretroviral therapy across China[J]. *Sci Rep*, 2017, 7(1): 3657. DOI: 10.1038/s41598-017-03968-3.
- [9] Trotta MP, Ammassari A, Murri R, et al. Sexual dysfunction in HIV infection[J]. *Lancet*, 2007, 369(9565): 905-906. DOI: 10.1016/S0140-6736(07)60446-2.
- [10] 谢美莲, 王爱平, 张志云. 艾滋病患者症状评估工具的开发与研究现状[J]. *中华现代护理杂志*, 2022, 28(4): 551-555. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20210521-02210.
- Xie ML, Wang AP, Zhang ZY. Current status of development and research on symptom assessment tools for HIV patients[J]. *Chin J Mod Nurs*, 2022, 28(4): 551-555.
- [11] 朱政, 胡雁, 周英凤, 等. 推动证据向临床转化(三)研究的选题和问题构建[J]. *护士进修杂志*, 2020, 35(9): 796-799. DOI: 10.16821/j.cnki.hsjx.2020.09.008.
- Zhu Z, Hu Y, Zhou YF, et al. Promoting the transformation of evidence to clinical practice: research topic selection and problem construction[J]. *J Nurs Train*, 2020, 35(9): 796-799.
- [12] 邢唯杰, 胡雁, 周英凤, 等. 推动证据向临床转化(四)以临床转化为目的的证据资源检索[J]. *护士进修杂志*, 2020, 35(10): 879-882. DOI: 10.16821/j.cnki.hsjx.2020.10.004.
- Xing WJ, Hu Y, Zhou YF, et al. Promoting evidence to clinical transformation: evidence resource retrieval for the purpose of clinical transformation[J]. *J Nurs Train*, 2020, 35(10): 879-882.
- [13] 高洪莲, 王春美, 王晓敏, 等. 非药物干预促进胃肠道恶性肿瘤患者术后功能恢复的最佳证据总结[J]. *中华护理杂志*, 2022, 57(2): 215-222. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2022.02.016.
- Gao HL, Wang CM, Wang XM, et al. Evidence summary for nonpharmacological interventions in promoting gastrointestinal function recovery after gastrointestinal malignancies surgery[J]. *Chin J Nurs*, 2022, 57(2): 215-222.
- [14] Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, et al. AGREE II: advancing guideline development, reporting, and evaluation in health care[J]. *Prev Med*, 2010, 51(5): 421-424. DOI: 10.1016/j.ypmed.2010.08.005.
- [15] 王春青, 胡雁. JBI 证据预分级及证据推荐级别系统(2014 版)[J]. *护士进修杂志*, 2015(11): 964-967. DOI: 10.16821/j.cnki.hsjx.2015.11.002.
- Wang CQ, Hu Y. JBI evidence pre-classification and evidence rank system (2014 Edition) [J]. *J Nurs Train*, 2015(11): 964-967.
- [16] 胡雁, 郝玉芳. 循证护理学[M]. 2 版. 北京: 人民卫生出版社, 2019.
- [17] Kryger MH, Malhotra A, Collop N. Obstructive sleep apnea overview of management in adults[EB/OL]. (2023-05-18) [2023-09-08]. <https://shl.uptodate.com/contents/zh-Hans/obstructive-sleep-apnea-overview-of-management-in-adults>.
- [18] Greene M, Gandhi RT. HIV infection in older adults[EB/OL]. (2023-01-17) [2023-09-08]. <https://shl.uptodate.com/contents/zh-Hans/hiv-infection-in-older-adults>.
- [19] Walston JD, Schumaker KE. Frailty[EB/OL]. (2023-06-12) [2023-10-08]. <https://shl.uptodate.com/contents/zh-Hans/frailty>.
- [20] Khera M, Snyder PJ. Treatment-of-male-sexual-dysfunction[EB/OL]. (2023-07-17) [2023-09-08]. <https://shl.uptodate.com/contents/zh-Hans/treatment-of-male-sexual-dysfunction>.
- [21] Shifren JL, Barbieri RL. Overview of sexual dysfunction in females management[EB/OL]. (2023-02-01) [2023-09-08]. <https://shl.uptodate.com/contents/zh-Hans/overview-of-sexual-dysfunction-in-females-management>.
- [22] Fosnocht KM, Ende J, Elmore JG. Approach-to-the-adult-patient-with-fatigue[EB/OL]. (2021-04-26) [2023-09-22]. <https://shl.uptodate.com/contents/zh-Hans/approach-to-the-adult-patient-with-fatigue>.
- [23] Pahuja M, Merlin J, Selwyn PA. Issues in HIV/AIDS in adults in palliative care[EB/OL]. (2021-04-26) [2023-09-08]. <https://shl.uptodate.com/contents/zh-Hans/issues-in-hiv-aids-in-adults-in-palliative-care>.
- [24] European Association of Urology. European Association of Urology guidelines on sexual and reproductive health[EB/OL]. (2021) [2023-10-08]. <https://uroweb.org/guidelines>.
- [25] European AIDS Clinical Society. European AIDS Clinical Society guidelines[EB/OL]. (2021-10-21) [2023-10-08]. <https://guide.medlive.cn/guideline>.
- [26] Riemann D, Baglioni C, Bassetti C, et al. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia[J]. *J Sleep Res*, 2017, 26(6): 675-700. DOI: 10.1111/jsr.12594.
- [27] Valdez, F. Sexual dysfunction (men): lifestyle interventions[EB/OL]. (2022-05-23) [2023-10-08]. <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=jbi&NEWS=N&AN=JBI12004>.
- [28] Oerlemans. Sexual dysfunction (women): lifestyle interventions[EB/OL]. (2022-12-12) [2023-10-08]. <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=jbi&NEWS=N&AN=JBI12003>.
- [29] 中华医学会呼吸分会睡眠呼吸障碍学组, 中国医学装备协会呼吸病装备技术专业委员会睡眠呼吸设备学组. 成人阻塞性睡眠呼吸暂停高危人群筛查与管理专家共识[J]. *中华健康管理学杂志*, 2022, 16(8): 520-528. DOI: 10.3760/cma.j.cn115624-20220615-00460.
- [30] Xiao X, Reynolds NR, Saligan L, et al. Effectiveness of non-pharmacological interventions to decrease fatigue in people living with HIV/AIDS: a protocol of systematic review and meta-analysis[J]. *BMJ Open*, 2020, 10(9): e040996. DOI: 10.1136/bmjopen-2020-040996.
- [31] Huntingdon B, Muscat DM, de Wit J, et al. Factors associated with general sexual functioning and sexual satisfaction among people living with HIV: a systematic review[J]. *J Sex Res*, 2020, 57(7): 824-835. DOI: 10.1080/00224499.2019.1689379.
- [32] De Crescenzo F, D'Alò GL, Ostinelli EG, et al. Comparative effects of pharmacological interventions for the acute and long-term management of insomnia disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis[J]. *Lancet*, 2022, 400(10347): 170-184. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)00878-9.
- [33] Ramirez Garcia MP, Leclerc-Loiselle J, Côté J, et al. Effect of autogenic training on quality of life and symptoms in people living with HIV: a mixed method randomized controlled trial[J].

- Complement Ther Clin Pract, 2023, 50: 101716. DOI: 10.1016/j.ctcp.2022.101716.
- [34] Han S, Pei Y, Zhao R, et al. Effects of a symptom management intervention based on group sessions combined with a mobile health application for persons living with HIV in China: a randomized controlled trial[J]. Int J Nurs Sci, 2021, 8(4): 370-379. DOI: 10.1016/j.ijnss.2021.07.002.
- [35] Alikhani M, Ebrahimi A, Farnia V, et al. Effects of treatment of sleep disorders on sleep, psychological and cognitive functioning and biomarkers in individuals with HIV/AIDS and under methadone maintenance therapy[J]. J Psychiatr Res, 2020, 130: 260-272. DOI: 10.1016/j.jpsychires.2020.07.043.
- [36] Kuloor A, Kumari S, Metri K. Impact of yoga on psychopathologies and quality of life in persons with HIV: a randomized controlled study[J]. J Bodyw Mov Ther, 2019, 23(2): 278-283. DOI: 10.1016/j.jbmt.2018.10.005.
- [37] 吕开月, 廖喜琳, 熊文琴, 等. HIV/AIDS 患者衰弱发生率及影响因素的 Meta 分析[J]. 中国艾滋病性病, 2023, 29(8): 948-953. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2023.08.25.
- Lyu KY, Liao XL, Xiong WQ, et al. Incidence and influencing factors of frailty in HIV/AIDS patients: a meta-analysis[J]. Chinese Journal of AIDS & STD, 2023, 29(8): 948-953.
- [38] 岳桂琴, 李宗煜, 王凡, 等. 艾滋病患者/感染者睡眠障碍状况的调查分析及影响因素研究[J]. 世界睡眠医学杂志, 2018, 5(11): 1331-1335. DOI: 10.3969/j.issn.2095-7130.2018.11.022.
- Yue GQ, Li ZY, Wang F, et al. Investigation and analysis of sleep disorder in AIDS patients/infected people and its influencing factors[J]. World Journal of Sleep Medicine, 2018, 5(11): 1331-1335.
- [39] Langseth R, Berg RC, Rysstad O, et al. Prevalence and predictors of fatigue among people living with HIV in Norway[J]. AIDS Care, 2022, 34(8): 1008-1013. DOI: 10.1080/09540121.2021.1934379.
- [40] Zhu Z, Hu Y, Guo M, et al. Urban and rural differences: unmet needs for symptom management in people living with HIV in China[J]. J Assoc Nurses AIDS Care, 2019, 30(2): 206-217. DOI: 10.1097/JNC.000000000000025.
- [41] Wohl D, Clarke A, Maggiolo F, et al. Patient-reported symptoms over 48 weeks among participants in randomized, double-blind, phase III non-inferiority trials of adults with HIV on Co-formulated Bictegravir, Emtricitabine, and Tenofovir Alafenamide versus Co-formulated Abacavir, Dolutegravir, and Lamivudine[J]. Patient, 2018, 11(5): 561-573. DOI: 10.1007/s40271-018-0322-8.
- [42] Abbas Q, Nisa M, Khan MU, et al. Brief cognitive behavior therapy for stigmatization, depression, quality of life, social support and adherence to treatment among patients with HIV/AIDS: a randomized control trial[J]. BMC Psychiatry, 2023, 23(1): 539. DOI: 10.1186/s12888-023-05013-2.
- [43] 田敏, 谢龙昇, 魏薇, 等. HIV 感染者自我管理健康教育内容体系的构建[J]. 中国艾滋病性病, 2023, 29(9): 992-996. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2023.09.09.
- [44] 刘阳, 王慧群, 张利漫, 等. 成人 HIV/AIDS 患者居家运动管理的最佳证据总结[J]. 护士进修杂志, 2023, 38(10): 908-913. DOI: 10.16821/j.cnki.hsjx.2023.10.010.
- Liu Y, Wang HQ, Zhang LM, et al. Summary of the best evidence for home exercise management in adult patients with HIV/AIDS[J]. J Nurs Train, 2023, 38(10): 908-913.
- [45] 陈翠霞. 肥胖型多囊卵巢综合征不孕病人生活方式干预研究进展[J]. 全科护理, 2021, 19(16): 2205-2208. DOI: 10.12104/j.issn.1674-4748.2021.16.012.

· 读者 · 作者 · 编者 ·

本刊关于稿件处理的要求

《中华现代护理杂志》关于稿件处理的要求如下。

1. 审稿制度: 中华医学会系列杂志实行以同行审稿为基础的三审制(编辑初审、专家外审、编辑委员会终审)。审稿过程中保护作者稿件的私密权。对不拟刊用的稿件将告知退稿意见, 对稿件处理有不同意见时, 作者有权申请复议, 并提出申诉的文字说明。

2. 稿件处理时限: 根据《中华人民共和国著作权法》, 并结合本刊实际情况, 凡接到本刊收稿回执后 2 个月内未接到稿件处理情况通知者, 则稿件仍在审阅中。作者如欲投他刊, 请务必事先与编辑部联系, 否则将视为一稿两投, 作退稿处理, 同时作者将被列入学术不端管理名单。已在非公开发行的刊物上发表, 或在学术会议交流过, 或已用其他文种发表过(需征得首次刊登期刊的同意)的文稿, 不属于一稿两投,

但作者在投稿时必须注明。

3. 作者对来稿的真实性及科学性负责。依照《中华人民共和国著作权法》有关规定, 本刊可对来稿做文字修改、删节。凡有涉及原意的修改, 则提请作者考虑。修改稿逾期 2 个月未返回者, 视作自动撤稿。

4. 撤稿: 对于存在以下问题的稿件编辑部有权在论文发表后撤稿。(1)已经证实论文存在较严重的不可信、学术不端(包括捏造数据和篡改数据)或者非主观的错误, 以至于该论文所报道的发现和结果不可信;(2)论文存在剽窃问题;(3)论文所报道的研究违反医学伦理规范;(4)重复发表;(5)在稿件发表流程中存在严重缺陷;(6)其他需要撤稿的情况。一经查实, 编辑部将按照《关于中华医学会系列杂志论文发表后撤稿的推荐规范》的要求处理。

